

Hiperventilación y síntomas físicos del pánico

Guía clínica para explicar el cuerpo durante una crisis

Explicar de forma creíble y precisa qué pasa en el cuerpo durante el pánico es una intervención psicoeducativa potente: reduce el miedo al miedo mismo.

QUÉ ES LA HIPERVENTILACIÓN

Respirar más rápido y/o más profundo de lo que el cuerpo necesita en reposo. Provoca una caída del CO₂ en sangre (hipocapnia), lo cual genera síntomas físicos intensos pero NO peligrosos: mareo, hormigueo, visión borrosa, sensación de falta de aire (paradójica), opresión en el pecho.

POR QUÉ SE SIENTE TAN PELIGROSO SIN SERLO

El sistema de lucha/huida se activa pensando que hay una amenaza real. Libera adrenalina, que acelera el corazón, tensa los músculos y redirige sangre hacia las extremidades — todo preparación evolutiva para correr o pelear, no señal de infarto o de “volverse loco”. El cuerpo está reaccionando de forma correcta a una amenaza que no está presente.

DATOS ÚTILES PARA PSICOEDUCAR CON AUTORIDAD

Una crisis de pánico tiene un pico definido y luego decae — el cuerpo no puede sostener la activación máxima de forma indefinida; fisiológicamente se autolimita. Los síntomas cardíacos del pánico (palpitaciones, opresión) no equivalen a riesgo cardíaco real en personas sin patología cardíaca previa — está ampliamente documentado. La sensación de “desmayo inminente” en el pánico rara vez se concreta: la presión arterial sube durante el pánico, lo opuesto a lo que provoca un desmayo real.

■ Clave clínica

Esta psicoeducación funciona mejor cuando se ancla en la experiencia propia del paciente ('¿Alguna vez una crisis no terminó? ¿Qué pasó realmente la última vez?') en lugar de presentarse solo como información abstracta.